

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE FUSIÓN COGNITIVA (CFQ-7)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional del Enredo Mental y la Literalidad del Pensamiento

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Fusión Cognitiva (CFQ-7).
Nombre Original (Inglés)	<i>Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ)</i>
Autores Originales	David T. Gillanders, Helen Bolderston, Frank W. Bond, Martin Dempster et al. (2014).
Validación Española / LatAm	Francisco J. Ruiz, Juan C. Suárez-Falcón, Diana Riaño-Hernández y D. Gillanders (2017).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Fusión vs. Defusión.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico unifactorial de 7 reactivos con escala Likert de 7 puntos (1 a 7).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde 15 años). Pacientes clínicos con trastornos emocionales y población general.
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto (Creative Commons / ACBS) para uso clínico, docente y de investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y TEORÍA DEL MARCO RELACIONAL (RFT)

En el marco de la Teoría del Marco Relacional (RFT) y la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes et al., 2006; Gillanders et al., 2014), la **fusión cognitiva** se define como la tendencia de los seres humanos a interactuar con los eventos privados verbales (pensamientos, juicios, evaluaciones o recuerdos dolorosos) como si fueran literalmente equivalentes a los acontecimientos que describen, en lugar de experimentarlos como meros sucesos mentales transitorios.

Cuando existe un alto grado de fusión cognitiva, el comportamiento del individuo pasa a estar dominado casi exclusivamente por reglas verbales inflexibles (“tengo que sentirme seguro para salir a la calle”, “si pienso que soy un fracaso, es porque lo soy”), anulando la sensibilidad a las contingencias del entorno directo y restringiendo el repertorio conductual.

Desde la neurobiología afectiva, la fusión cognitiva refleja una hiperconectividad de la Red Neuronal por Defecto (DMN; corteza prefrontal medial y precúneo) asociada al ensimismamiento rumiante, con una modulación ineficiente por parte de la red de control ejecutivo frontoparietal y la red de prominencia insular. La alternativa terapéutica, la **defusión cognitiva**, promueve una postura de distanciamiento desidentificado ante el flujo mental.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Ítem	Contenido Literal del Reactivo en Español (Ruiz et al., 2017)	Sentido	Faceta Fenomenológica
1	Mis pensamientos me causan angustia o dolor emocional.	Directo	Afecto aversivo reactivo
2	Me enredo tanto en mis pensamientos que no puedo hacer lo que realmente quiero.	Directo	Interferencia conductual
3	Tiendo a apegarme a mis pensamientos.	Directo	Fijación cognitiva / Apego
4	Me siento abrumado/a por mis pensamientos.	Directo	Sobrecarga subjetiva
5	Me quedo tan atrapado/a en mis pensamientos que parezco estar en piloto automático.	Directo	Pérdida de presencia / Piloto
6	Me cuesta mucho dejar ir pensamientos perturbadores, incluso sabiendo que me ayudaría.	Directo	Inflexibilidad para soltar
7	Me desanimo fácilmente por mis pensamientos.	Directo	Impacto motivacional directo

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Precisión psicométrica excepcional: alfa de Cronbach de 0.93 en muestra clínica con trastornos emocionales, 0.93 en población general online y 0.89 en universitarios (N = 1,763; Ruiz et al., 2017). Correlaciones ítem-total corregidas entre 0.73 y 0.85.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio verificó una estructura unifactorial pura con índices de ajuste óptimos: $\chi^2(14) = 135.56$, CFI = 0.98, NNFI = 0.98, RMSEA = 0.070. Cargas factoriales estandarizadas entre 0.79 y 0.88.
Validez Concurrente y Criterio	Correlaciones muy elevadas con inflexibilidad psicológica (AAQ-II: $r = 0.76$ a 0.84), depresión (BDI-II: $r = 0.57$ a 0.70), ansiedad (STAI: $r = 0.49$ a 0.60) y estrés (DASS-21: $r = 0.53$ a 0.68). Correlación negativa con satisfacción vital (SWLS: $r = -0.36$ a -0.53) y mindfulness (MAAS: $r = -0.34$).
Invarianza de Medida	Estricta invarianza factorial métrica y escalar entre submuestras clínicas y comunitarias, así como entre hombres y mujeres (Delta CFI > -0.01, Delta RMSEA < 0.01).
Sensibilidad al Cambio Clínico	Extraordinaria responsividad en ensayos clínicos: tras 1 única sesión de defusión ACT focalizada, la puntuación media en pacientes clínicos descendió de 30.27 a 19.36 con un tamaño de efecto masivo (d de Cohen = 1.89).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 7 reactivos se responde en una escala Likert de 7 puntos (1 = «Nunca es verdad», 2 = «Muy rara vez», 3 = «Rara vez», 4 = «A veces», 5 = «Frecuentemente», 6 = «Casi siempre», 7 = «Siempre es verdad»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo):** No contiene ítems invertidos. Se suman las puntuaciones asignadas a los 7 reactivos.
- **Paso 2 (Puntuación Total CFQ-7):** Puntuación Total = $\sum_{i=1}^7 \text{Ítem}_i$.
- **Rango Teórico Global: 7 a 49 puntos.** A mayor puntuación, mayor severidad de la fusión cognitiva y la dominancia verbal.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS (RUIZ ET AL., 2017)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Fusión Cognitiva	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo / Adaptativo	7 a 23 puntos	Defusión psicológica adecuada	Pensamientos percibidos como representaciones no deterministas. Flexibilidad conductual óptima.
Moderado	24 a 30 puntos	Fusión reactiva / Subclínica	Enredo mental ante crisis específicas o sobrecarga laboral. Psicoeducación en defusión y atención plena.
Clínico / Elevado	31 a 38 puntos	Fusión clínicamente significativa (corte ≥ 31)	Patrón desadaptativo consolidado. Creencia literal en contenidos autocríticos. Indicación formal de ACT.
Severo / Extremo	39 a 49 puntos	Enredo cognitivo masivo e invalidante	Parálisis casi absoluta de la acción guiada por valores. Fusión catastrófica. Riesgo alto de cronificación.

BAREMOS COMPARATIVOS NORMATIVOS (N = 1,763):

• **Población Universitaria (N = 762):** Media = 20.87 (DE = 8.70). • **Población Comunitaria General (N = 724):** Media = 23.80 (DE = 10.36). • **Muestra Clínica con Trastornos Emocionales (N = 277):** Media = 31.53 (DE = 10.86). El **punto de corte de ≥ 31 puntos** discrimina con alta precisión entre población clínica y no clínica (sensibilidad del 79% y especificidad del 81%).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN FUSIÓN COGNITIVA (ACT)

PROTOCOLO DE DEFUSIÓN CLÍNICA BASADO EN EL CFQ-7:

- **Paso 1 (Detección de la Literalidad):** Identificar las frases mentales nucleares que paralizan al paciente (“no soy capaz”, “mi vida es un desastre”). Explicar que tener un pensamiento no obliga a obedecerlo.
- **Paso 2 (Técnicas Experienciales de Defusión):** Aplicar ejercicios de distanciamiento lingüístico: prefijar “Estoy teniendo el pensamiento de que...”, repetición rápida de una palabra clave hasta perder su significado léxico (ejercicio de la leche de Titchener), nombrar la mente (“mi mente me está contando la historia de la incompetencia”).
- **Paso 3 (Monitorización Sensible):** El CFQ-7 es ideal como medida de proceso sesión a sesión. Un descenso de **>= 8 puntos** señala el restablecimiento del contacto con la experiencia presente y la acción comprometida.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN Y RUMIACIÓN FUSIONADA

Identificación: Paciente femenina de 29 años, docente de secundaria, derivada por cuadro depresivo mayor persistente caracterizado por intensa rumiación autocrítica, aislamiento y bloqueo laboral tras una evaluación docente adversa.

Evaluación Inicial CFQ-7 (Línea Base): Puntuación Total = **44 puntos** (Rango Severo / Extremo). Ítems 1, 2, 4, 6 calificados con 7/7 (“Mis pensamientos me causan angustia”, “Me quedo atrapada”, “No puedo hacer lo que quiero”). Coexistía un BDI-II de 34 puntos y AAQ-II de 41 puntos.

Intervención Aplicada: Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Se implementaron ejercicios de “pasajeros en el autobús”, donde las autocríticas eran tratadas como pasajeros ruidosos e intimidantes pero sin control sobre el volante del vehículo de sus valores docentes. Se practicó el etiquetado consciente (“pensando, evaluando”) en situaciones de activación.

Reevaluación a las 8 Semanas: CFQ-7 = **19 puntos** (descenso neto de 25 puntos, normalización al Rango Adaptativo). La paciente reanudó sus clases y verbalizó: “Los pensamientos de ineptitud siguen viniendo, pero ahora sé que solo son palabras que fabrica mi cerebro, no órdenes que deba acatar”.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

FUSIÓN VS. PENSAMIENTO DELIRANTE:

En la fusión cognitiva intensa los pensamientos son vividos como verdades incuestionables, pero el paciente conserva la capacidad de verificar la realidad externa con guía clínica. Si la convicción es inquebrantable a pesar de pruebas irrefutables en contra, evaluar psicosis o ideas delirantes.

DEFUSIÓN VS. DISOCIACIÓN EVITATIVA:

La defusión promueve una presencia lúcida, afectuosa y flexible con el propio pensar. No debe confundirse con estrategias de despersonalización, desconexión anestesiante o distanciamiento cínico, las cuales constituyen formas encubiertas de evitación experiencial disfuncional.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Riaño-Hernández, D., & Gillanders, D. (2017). Psychometric properties of the Cognitive Fusion Questionnaire in Colombia. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 49(1), 80-87.
2. Gillanders, D. T., Bolderston, H., Bond, F. W., Dempster, M., Flaxman, P. E., Campbell, L., ... & Remington, B. (2014). The development and initial validation of the Cognitive Fusion Questionnaire. *Behavior Therapy*, 45(1), 83-101.
3. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. *Behaviour Research and Therapy*, 44(1), 1-25.
4. Bolderston, H., et al. (2019). The Cognitive Fusion Questionnaire: A review of international adaptations and psychometric properties. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 12, 128-137.